Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo

Av. Unisinos, 99 - Bairro: São João Batista - CEP: 93022414 - Fone: (51) 3590-1299 - Balcão Virtual (Whatsapp): 51 98035.2866 - Email: frsaoleo5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000942-17.2022.8.21.0033/RS

AUTOR: ADAO CARLOS RODRIGUES PEDROSO

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por **ADAO CARLOS RODRIGUES PEDROSO** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.** Em síntese, narrou que é portador da patologia compatível com o CID-10 C91.1, Leucemia Linfocítica Crônica. Afirmou que necessita do medicamento IBRUTINIBE, 420mg/dia, cada comprimido contém 140 mg, ou seja, necessita de 3 comprimidos por dia, 90 comprimidos ao mês. Aduziu que solicitou o medicamento de forma administrativa, mas o pedido foi indeferido com justificativa de que a medicação não faz parte dos medicamentos atendidos via Sistema Único de Saúde. Discorreu sobre o direito que entende aplicável. Requereu a concessão de tutela antecipada, a fim de que fosse determinada à parte demandada a disponibilização em favor da parte autora do tratamento prescrito, de forma imediata. No mérito, pugnou pela procedência do pedido. Postulou pela gratuidade da justiça. Acostou documentos.

Intimada a parte autora para trazer documentação comprobatória da necessidade do benefício da AJG (evento 3, DESPADEC1), o que foi atendido pela parte autora ao evento 6, PET5.

Concedida a gratuidade da justiça e deferida a tutela de urgência postulada ao evento 9, DESPADEC1.

A parte ré interpôs agravo de instrumento ao evento 22, no qual restou foi reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com a União e, por conseguinte, declinou da competência à Justiça Federal (evento 22, RELVOTO1).

No evento 22, RELVOTO1, do recurso interposto, o processo foi sobrestado até o julgamento do TEMA 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal.

O Estado apresentou contestação ao evento 23, CONT1. Preliminarmente, alegou a necessidade de aplicação das teses firmadas pelos tribunais superiores. No mérito, sustentou que a legislação vigente afasta a necessidade de custeio de tratamento oncológico quando a pessoa não realizou primeiro atendimento na rede pública e que após confirmação do diagnóstico na rede pública, deve o paciente ser encaminhado as unidades CACON e UNACON. Ainda, afirmou que o medicamento postulado é de alto custo e que existe repercussão geral controversa sobre a obrigatoriedade de fornecimento pelo poder público. Postulou a inclusão da União no polo passivo e improcedência dos pedidos.

Réplica ao evento 27, RÉPLICA1.

Intimadas as partes para produção de novas provas (evento 31, DESPADEC1), a parte ré postulou a intimação da autora para informar se buscou atendimento no UNACON/CACON (evento 38, PET1).

Por sua vez, a parte autora postulou pelo bloqueio de valores, visto que não recebeu o medicamento em setembro de 2022 (evento 41, PET1).

Sobreveio manifestação do Ministério Público, opinando pela procedência dos pedidos da autora (evento 44, PROMOÇÃO1).

Efetuado bloqueio de valores ao evento 46, DESPADEC1. Foi restituido os valores, após informação do autor de que foi disponibilizado o medicamento (evento 75, DESPADEC1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Passo a fundamentar.

II - Fundamentação

Analisando os autos, vejo que o feito tramitou de forma regular, não havendo quaisquer nulidades a ser declaradas ou atos anuláveis pendentes de cognição do juízo. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao enfrentamento da demanda proposta.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Rio Grande do Sul, com objetivo de determinar que o ente forneça o medicamento IBRUTINIBE, 420mg/dia ao autor que é portador da patologia compatível com o CID-10 C91.1, Leucemia Linfocítica Crônica.

Entendo que anteriormente, nas demandas em que se buscasse o fornecimento de tratamento, procedimento, material ou medicamento oncológico custeado pela União, havia de ser possibilitada a emenda da inicial para inclusão do ente federal no polo passivo por aplicação do precedente oriundo do julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário 855.178/SE (TEMA 793).

Contudo, após decisão proferida nos autos do RE n.º 1366243 (Tema 1234), imperioso proceder à adequação do entendimento adotado na hipótese, visando à uniformização da jurisprudência sobre a matéria.

O Ministro Gilmar Mendes, ao deferir parcialmente a tutela provisória nos autos do RE n.º 1366243 (Tema 1234), determinou que as ações com sentença prolatada até a data da mencionada decisão (17/04/2023) devem permanecer sob a competência do Juízo sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução; *in verbis:*

> *(i)* ***nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados****: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;*
>
> *(ii)* ***nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados****: devem ser processadas e julgadas pelo* ***Juízo****, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;*
>
> *(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos* ***sem sentença prolatada****; diferentemente, os processos* ***com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023)*** *devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);*
>
> *(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".*
>
> *(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". - grifei*

Assim, considerando que no presente caso a sentença está sendo prolatada após a data de 17/04/2023, **cabível a manutenção do feito nesta Justiça Estadual.**

Quanto à necessidade de **inclusão da União no polo passivo** da demanda, impõe-se, como referido anteriormente, cumprir o item "*ii*" da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE nº 1366243 (Tema 1234). Assim, permanece hígido o processamento e julgamento do pedido perante esta Justiça Estadual.

No que se refere à legitimidade passiva dos entes federados demandados, deve ser observado o precedente oriundo do julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário 855.178/SE (TEMA 793).

Entende-se que a Constituição da República, em seu artigo 196 e seguintes, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento dos serviços de saúde. Com efeito, as ações e os serviços públicos de saúde das três esferas compõem um sistema único, de tal modo que qualquer dos entes da Federação é parte legítima para responder à demanda que objetiva tais prestações.

Ou seja, a distribuição de competências no Sistema Único de Saúde (Lei nª 8.080/90) não possui o condão de afastar a responsabilidade solidária dos entes públicos. A organização interna da gestão da Saúde Pública não foi estabelecida como restrição ao exercício da pretensão de demandar assistência.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Tema 793, reafirmou a competência solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos, *in verbis*:

> *"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"(PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)*

Desse modo, qualquer bloqueio de valores será precedido da impossibilidade de fornecimento do tratamento via SUS e, a partir disso, possibilitar o procedimento de ressarcimento pelo ente que suportou o ônus financeiro frente aos demais.

Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 106, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

> *i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
>
> *ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
>
> *iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

Na hipótese, a parte autora comprovou, por meio idôneo, que necessita fazer uso do medicamento IBRUTINIBE, uma vez que os fármacos disponibilizados pelo SUS não apresentaram resposta positiva (evento 1, LAUDO8 e evento 1, LAUDO9), e, ainda, que não tem condições financeiras de custear o tratamento. Além disso, o medicamento encontra-se devidamente registrado na ANVISA.

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Resultado da Consulta de Produtos

	Nome Comercial	Princípio Ativo	Registro	Processo	Nome da Empresa Detentora do Registro – CNPJ	Situação	Vencimento
☐	IMBRUVICA	ibrutinibe	112363439	25351.114441/2020-91	JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA - 51.780.468/0001-87	Válido	10/2032
☐	Imbruvica	ibrutinibe	112363412	25351.435416/2014-08	JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA - 51.780.468/0001-87	Válido	07/2025

Comprovada a carência financeira da parte autora, é descabida a alegação de insuficiência de previsão orçamentária do Estado, já que o direito à vida deve prevalecer sobre regras de natureza formal. Não deve ser afastada do réu a incumbência de fornecer o medicamento de alto custo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 793 DO STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO. VEDAÇÃO. TEMA 1234 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALTO CUSTO. 1. Nas ações relativas à dispensação de tratamentos, procedimentos, materiais, insumos ou medicamentos não incorporados ao SUS, por ora, está vedada a determinação de inclusão da União. Aplicação da tutela provisória incidental concedida pelo STF no RE 1.366.243 (Tema 1.234). 2. Tema 106 do STJ. "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Hipótese em que os requisitos foram preenchidos cumulativamente. 3. ***O fato de se tratar de fármaco de alto custo não exime o Poder Público da obrigação de dispensá-lo, ante a prova de sua necessidade. Jurisprudência deste Tribunal****. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, Nº 51235088220238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 09-05-2023) (Grifo meu)*

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ESTADO E MUNICÍPIO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSOS QUESTIONAMENTOS. 1. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO MERECE CONHECIDA. CABE REFERIR QUE A SENTENÇA QUE CONDENA O PODER PÚBLICO A CUSTEAR MEDICAMENTO É DECISÃO LÍQUIDA; PORTANTO, DESCABE REMESSA NECESSÁRIA, NEM MESMO PELO SÚMULA 490 DO STJ, APLICÁVEL SOMENTE ÀS SENTENÇAS ILÍQUIDAS. 2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE IGUAL MODO, NÃO MERECE ACOLHIDA, VISTO QUE O PROPÓSITO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA É QUESTIONAR A ORIENTAÇÃO DO MÉDICO DA PACIENTE. SABIDAMENTE, PERITO É MÉDICO DO PACIENTE. NINGUÉM MAIS HABILITADO DO QUE ELE PARA DIZER QUAL É, CONSIDERADA A ESPECIFICIDADE, O REMÉDIO MAIS ADEQUADO E EFICIENTE. 3. SOLIDARIEDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO FACE A QUEM PRECISA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (STF – TEMA 793). A EXPRESSÃO ESTADO NO ART. 196 DA CF REFERE-SE AO PODER PÚBLICO LATO SENSU (UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS), E A SOLIDARIEDADE NÃO SE REFERE AOS ENTES DA FEDERAÇÃO ENTRE SI, PORQUE ENTRE SI VIGORA A REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA. A SOLIDARIEDADE REFERE-SE A CADA ENTE FACE A QUEM PRECISA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SALVO QUANDO RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO (STF – TEMA 500), CADA ENTE RESPONDE PELA INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA, ISTO É, INDEPENDENTEMENTE DE A NECESSIDADE SER DE BAIXA, MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE. A REFERÊNCIA, NA SEGUNDA PARTE DO TEMA 793 DO STF, DE RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO E QUE, PELA REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA, NÃO LHE CABIA, NÃO QUER DIZER QUE O DIREITO DE REGRESSO DEVE OCORRER NA MESMA AÇÃO, SOB PENA DE, EM TODAS AS DEMANDAS, SER NECESSÁRIO INCLUIR NO POLO PASSIVO TODOS OS ENTES, NUMA VERDADEIRA LITISDENUNCIAÇÃO DISFARÇADA. AS AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE RECLAMAM TRAMITAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA. NÃO PODEM SER TUMULTUADAS POR QUESTÕES QUE NÃO DIZEM ESTRITAMENTE COM O DIREITO DO ENFERMO, COMO ACONTECE SE SE ADMITIR A DISCUSSÃO DO REPASSE DA RESPONSABILIDADE DE UM ENTE AO OUTRO COM BASE DA REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA. 4. MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA (STF – TEMA 500). SE O FÁRMACO NÃO TEM REGISTRO NA ANVISA, OU SE ESTA INCORRE EM MORA (= ULTRAPASSA OS PRAZOS PREVISTOS PARA JULGAR O PEDIDO DE LIBERAÇÃO), A RESPONSABILIDADE PELA DISPENSAÇÃO, NAS HIPÓTESES DEFINIDAS PELO STF, É EXCLUSIVA DA UNIÃO. 5. ***MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (STF – TEMA 6). ALÉM DE NÃO TER HAVIDO SUSPENSÃO GERAL, O STF, EMBORA TENHA RECONHECIDO A INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ESTADO, QUANDO O FÁRMACO NÃO ESTIVER PREVISTO NA RELAÇÃO DO PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO SUS, AINDA NÃO DEFINIU AS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NA FORMULAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL****. 6. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA (STJ – TEMA 106). SE O FÁRMACO RECEITADO PELO MÉDICO TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTA NA LISTA DO SUS, PORÉM O SUS FORNECE OUTRO MEDICAMENTO PARA A MOLÉSTIA, A RESPONSABILIDADE, FACE A QUEM NECESSITA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, É DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS), DESDE QUE PROVADOS DOIS REQUISITOS: (A) LAUDO DO MÉDICO DO PACIENTE NO SENTIDO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO RECEITADO E A INEFICÁCIA DOS FORNECIDOS PELO SUS, POR EXEMPLO, QUE JÁ FORAM UTILIZADOS SEM SUCESSO; E (B) INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE PARA SUPORTAR O CUSTO. 7. USO OFF LABEL OU FORA DA BULA OU DO PROTOCOLO DA ANVISA. O FATO DO USO OFF LABEL OU FORA DA BULA OU DO PROTOCOLO DA ANVISA, NÃO EXCLUI A SOLIDARIEDADE DE CADA ENTE DA FEDERAÇÃO FACE AO PACIENTE. IMPORTA É QUE HÁ LIBERAÇÃO. APENAS QUE, EM TAL OCORRÊNCIA, É IMPRESCINDÍVEL JUSTIFICATIVA MÉDICA PARA O USO DO MEDICAMENTO PARA MOLÉSTIA DIVERSA DAQUELA LIBERADA PELA ANVISA, BEM ASSIM A INEFICÁCIA DOS FORNECIDOS PELO SUS, POR EXEMPLO, QUE JÁ FORAM UTILIZADOS SEM SUCESSO. 8. CASO SUB JUDICE EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO JUSTIFICANDO O USO DE FÁRMACO LIBERADO PELA ANVISA E QUE NÃO CONSTA NA LISTA DO SUS. AINDA, EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE ALTO CUSTO DO TRATAMENTO, VALE ACRESCENTAR QUE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO PODE SER MEDIDA PELO VALOR NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO. 9. DISPOSITIVO REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA E PROVIDA EM PARTE A DO MUNICÍPIO.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50010908920208210003, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 31-03-2021). (Grifo meu)*

Nesse contexto, considerando que os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ foram devidamente preenchidos através da documentação anexada aos autos, ficou evidenciada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, indispensável à manutenção de sua saúde e de sua vida, sendo imperioso o acolhimento da pretensão apresentada.

III - Dispositivo

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos deduzidos por **ADAO CARLOS RODRIGUES PEDROSO** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** tornando definitiva a tutela de urgência concedida e determinando o fornecimento do medicamento IBRUTINIBE 420mg/dia, cada comprimido contém 140 mg, necessita de 3

comprimidos por dia, 90 comprimidos ao mês, pelo tempo que for necessário, com a periodicidade e dosagem determinadas pelo médico responsável pela parte autora.

Cientifique-se a parte autora de que **a prescrição médica deverá ser atualizada a cada 6 (seis) meses junto ao ponto de distribuição de medicamentos** da Secretaria Estadual da Saúde do RS – Farmácia de Medicamentos do Estado ou outro local, dado que, embora a indicação de uso contínuo, faz-se necessário o acompanhamento do tratamento para verificação do uso efetivo e do resultado apresentado.

Isento o demandado do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais, consoante o previsto no art. 5º, inciso I, da Lei 14.634/14.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo IGP-M, a contar da publicação da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da presente decisão, considerando o tempo de tramitação do feito, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Intimadas as partes.

Transitado em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **JAQUELINE HOFLER, Juíza de Direito**, em 26/4/2024, às 7:55:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10059005055v7** e o código CRC **4766f79a**.